

Parasitosis intestinales

1. Introducción y relevancia clínica

Las **parasitosis intestinales** son infecciones producidas por protozoos y helmintos que habitan o invaden el tubo digestivo humano.

Constituyen una **importante causa de morbilidad mundial**, especialmente en países en desarrollo, y aunque su prevalencia ha disminuido en Chile gracias al mejoramiento sanitario, siguen siendo frecuentes en sectores rurales, en población infantil y en personas con hacinamiento o malas condiciones higiénicas.

En el contexto chileno, los agentes más relevantes son:

- **Giardia lamblia (Giardia intestinalis)**
- **Entamoeba histolytica**
- **Enterobius vermicularis (oxiuro)**
- **Ascaris lumbricoides**
- **Trichuris trichiura**
- **Taenia solium y saginata**
- **Strongyloides stercoralis**

Estas infecciones son **de notificación obligatoria selectiva** cuando se presentan brotes (especialmente giardiasis y amebiasis).

En el **EUNACOM**, suelen abordarse mediante casos clínicos de diarrea crónica, anemia, malabsorción o prurito anal, enfocándose en el **diagnóstico diferencial y tratamiento antiparasitario adecuado**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Los parásitos intestinales se dividen en dos grandes grupos:

- **Protozoos:** organismos unicelulares que se reproducen en el intestino delgado o grueso. Ejemplo: *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*.
- **Helmintos:** gusanos multicelulares (nemátodos, cestodos y tremátodos) que pueden vivir en el lumen intestinal o migrar a otros tejidos. Ejemplo: *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*.

La transmisión es fundamentalmente **fecal-oral**, a través de ingestión de quistes o huevos en agua o alimentos contaminados. En algunos casos, las larvas penetran la piel (como *Strongyloides stercoralis* o *Ancylostoma duodenale*).

El ciclo vital incluye habitualmente una **fase ambiental (huevos o quistes resistentes)** y una **fase parasitaria en el huésped humano**.

El daño tisular ocurre por invasión directa, inflamación, competencia por nutrientes o reacción inmunoalérgica del huésped.

Los síntomas dependen del agente causal, la carga parasitaria y el estado nutricional e inmune del paciente.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Giardiasis

Causada por *Giardia lamblia*, protozoo flagelado que coloniza el intestino delgado.

Se transmite por agua o alimentos contaminados con quistes, o por contacto persona a persona en guarderías.

Síntomas principales:

- Diarrea intermitente o crónica, fétida, sin sangre.
- Meteorismo, dolor abdominal, náuseas.
- Esteatorrea (heces grasosas).
- Pérdida de peso y signos de malabsorción (en casos prolongados).

Fisiopatología: el parásito se adhiere a la mucosa duodenal, causando atrofia de vellosidades e interferencia con la absorción de grasas y vitaminas.

Diagnóstico diferencial: intolerancia a lactosa, enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable.

3.2. Amebiasis

Producida por *Entamoeba histolytica*, protozoo que puede tener formas comensales (*E. dispar*) o patógenas.

Se adquiere por ingestión de quistes en agua o alimentos contaminados.

El parásito invade la mucosa del colon, produciendo úlceras en “botón de camisa”.

Manifestaciones clínicas:

- Diarrea con moco y sangre.
- Dolor abdominal tipo cólico.
- Fiebre baja.

- En casos graves: disentería amebiana.

Puede diseminarse por vía portal hacia el hígado, causando **absceso hepático amebiano**, con fiebre alta y dolor en hipocondrio derecho.

Diagnóstico diferencial: colitis bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal, giardiasis.

3.3. Oxiuriasis (Enterobiasis)

Producida por *Enterobius vermicularis* (oxiuro), nemátodo pequeño que habita el colon y recto.

Las hembras depositan huevos en el margen anal durante la noche, generando **prurito anal intenso** que favorece la autoinoculación (vía ano-mano-boca).

Síntomas típicos:

- Prurito anal nocturno.
- Irritabilidad, insomnio, bruxismo.
- En niñas: vulvovaginitis por migración de los parásitos.

Diagnóstico diferencial: dermatitis perianal, candidiasis, prurito inespecífico.

3.4. Ascariasis

Causada por *Ascaris lumbricoides*, el nemátodo intestinal más grande del ser humano.

Se adquiere al ingerir huevos embrionados presentes en suelo contaminado.

Las larvas eclosionan en el intestino, migran por vía hematógica al pulmón, ascienden por el árbol bronquial y se degluten nuevamente, completando su ciclo en el intestino delgado.

Manifestaciones clínicas:

- En fase larvaria pulmonar: tos, disnea, sibilancias (síndrome de Löeffler).
- En fase intestinal: dolor abdominal, náuseas, malestar, distensión.
- Carga parasitaria alta: obstrucción intestinal o colangitis por migración a vías biliares.

Diagnóstico diferencial: otras causas de abdomen agudo, bronquitis eosinofílica.

3.5. Trichuriasis

Producida por *Trichuris trichiura*, que coloniza el ciego y colon ascendente.

El cuadro suele ser leve o asintomático, aunque en infecciones masivas puede causar diarrea crónica, tenesmo y prolapso rectal en niños.

Diagnóstico diferencial: síndrome disentérico bacteriano o amebiano.

3.6. Teniasis

Producida por *Taenia saginata* (vaca) o *Taenia solium* (cerdo).

El contagio se produce al ingerir carne cruda o mal cocida con cisticercos.

El parásito adulto vive en el intestino delgado y puede alcanzar varios metros de longitud.

Síntomas:

- Dolor abdominal leve, náuseas, baja de peso.
- Eliminación espontánea de proglótides (segmentos del parásito) por el ano.

En *T. solium*, la ingestión de huevos (no de cisticercos) produce **cisticercosis**, donde las larvas se alojan en tejidos, especialmente el sistema nervioso central (neurocisticercosis), causando convulsiones o hipertensión endocraneana.

3.7. Strongyloidiasis

Causada por *Strongyloides stercoralis*, nemátodo que penetra la piel (habitualmente pies descalzos).

Las larvas migran a pulmón y luego al intestino delgado, donde se reproducen.

Puede permanecer latente por años.

En inmunocomprometidos, puede producir **autoinfección masiva** con diseminación sistémica (síndrome de hiperinfección), potencialmente mortal.

Síntomas: diarrea, dolor abdominal, rash urticariano, tos, eosinofilia persistente.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de las parasitosis intestinales se basa en la **demostración del parásito o sus formas diagnósticas en las heces**.

Examen parasitológico seriado de deposiciones

- Solicitar **3 muestras en días alternos**, aumentando la sensibilidad diagnóstica.
- Permite identificar quistes (Giardia, Entamoeba), huevos (Ascaris, Trichuris, Taenia) o larvas (Strongyloides).
- En oxiuriasis, el examen habitual puede ser negativo.

Test de Graham (cinta adhesiva anal)

- Es el método diagnóstico de elección para **Enterobius vermicularis**.
- Se aplica una cinta adhesiva en región perianal en la mañana antes del aseo; se examina al microscopio para detectar huevos.

Otros exámenes

- **Hemograma:** eosinofilia orienta a helmintiasis.
- **Serología o PCR:** útil en amebiasis extraintestinal o cisticercosis.
- **Ecografía o TAC:** para absceso hepático amebiano o cisticercosis.

Comentario EUNACOM:

En paciente con diarrea fétida y esteatorrea → sospechar giardiasis. Si hay moco y sangre → amebiasis. Si hay prurito anal → oxiuriasis.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y OPS 2023–2024)

El tratamiento antiparasitario depende del agente causal:

- **Giardiasis:** Metronidazol 15 mg/kg/día en 3 dosis por 5–7 días. Alternativas: tinidazol dosis única o albendazol 400 mg/día por 5 días.
- **Amebiasis intestinal:** Metronidazol 750 mg cada 8 h por 10 días, seguido de un agente luminal (paramomicina o iodoquinol) para erradicar quistes.
 - Absceso hepático amebiano: Metronidazol 750 mg cada 8 h por 10 días + drenaje si es grande o complicado.
- **Oxiuriasis:** Mebendazol 100 mg VO dosis única, repetir en 2 semanas (tratar a todos los convivientes). Alternativa: albendazol 400 mg dosis única.
- **Ascariasis / Trichuriasis:** Albendazol 400 mg VO por 3 días o mebendazol 100 mg cada 12 h por 3 días.
- **Teniasis:** Praziquantel 10 mg/kg VO dosis única o niclosamida.
- **Strongyloidiasis:** Ivermectina 200 µg/kg/día por 2 días o albendazol 400 mg por 7 días.

Medidas generales:

- Reforzar higiene personal, lavado de manos y alimentos.
- Evitar consumo de agua no tratada.
- Controlar contactos familiares y compañeros en casos de giardiasis y oxiuriasis.

6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones varían según el agente:

- **Giardiasis:** malabsorción crónica, retraso ponderal, deficiencia de vitaminas liposolubles.
- **Amebiasis:** colitis necrosante, perforación intestinal, absceso hepático, extensión pleuropulmonar o cerebral.
- **Oxiuriasis:** vulvovaginitis, infecciones urinarias, prurito intenso con insomnio.
- **Ascariasis:** obstrucción intestinal, apendicitis, colangitis por migración.
- **Trichuriasis:** prolapso rectal, anemia por pérdidas crónicas.
- **Teniasis:** cisticercosis (neurológica o ocular).
- **Strongyloidiasis:** diseminación sistémica fatal en inmunocomprometidos.

El pronóstico es excelente en la mayoría de los casos con tratamiento adecuado.

Las infecciones repetidas o no tratadas pueden generar desnutrición y déficit cognitivo, especialmente en niños.

7. Prevención

Las estrategias preventivas son fundamentales y de alto impacto sanitario:

1. **Saneamiento ambiental:** eliminación adecuada de excretas y acceso a agua potable.
 2. **Educación sanitaria:** lavado de manos antes de comer y después de defecar.
 3. **Higiene alimentaria:** lavado de frutas y verduras, cocción adecuada de carnes.
 4. **Evitar andar descalzo:** especialmente en suelos húmedos.
 5. **Control escolar y desparasitación periódica:** recomendada por MINSAL cada 6 meses en zonas rurales o con brotes.
 6. **Tratamiento simultáneo de convivientes:** clave en oxiuriasis y giardiasis.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Diarrea crónica fétida sin sangre → **Giardia lamblia**.
2. Diarrea con moco y sangre → **Entamoeba histolytica**.
3. Prurito anal nocturno → **Enterobius vermicularis**.
4. Tos y eosinofilia → **Ascaris lumbricoides (fase pulmonar)**.
5. Eliminación de segmentos por el ano → **Teniasis**.

6. En inmunodeprimidos, eosinofilia persistente y autoinfección → **Strongyloides stercoralis**.
7. Tratar siempre a convivientes en oxiuriasis.
8. En amebiasis, después del metronidazol debe darse un **agente luminal** para eliminar quistes.

Errores comunes:

- Indicar tratamiento parcial (sin fase luminal en amebiasis).
 - No repetir dosis en oxiuriasis.
 - No controlar contactos domiciliarios.
 - Confundir *E. dispar* (no patógena) con *E. histolytica*.
 - Usar antibióticos en lugar de antiparasitarios.
 - Omitir medidas de higiene ambiental.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **parasitosis intestinales** son frecuentes en Chile, especialmente en zonas rurales y población infantil.
2. Los principales agentes son *Giardia lamblia*, *E. histolytica*, *Enterobius vermicularis* y *Ascaris lumbricoides*.
3. El **examen parasitológico seriado de deposiciones** es la herramienta diagnóstica fundamental.
4. El tratamiento se basa en antiparasitarios específicos (metronidazol, albendazol, mebendazol, praziquantel, ivermectina).
5. En amebiasis, siempre se debe asociar un **fármaco luminal** tras el metronidazol.
6. La **higiene personal, el saneamiento básico y la desparasitación periódica** son pilares de prevención.
7. En el **EUNACOM**, las preguntas enfatizan el **diagnóstico clínico diferencial y el antiparasitario correcto**.